EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 77453
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-01-16 12:35:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ELIANA DEL C MARTINEZ RODRIGUEZ			RUN	: 7.643.783-1
F.Nac	: 02-01-1952	Edad	: 72 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	: BRASIL 1060			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 412224		
Fecha Ingreso	: 2024-01-14	Fecha Egreso	: 2024-01-16 12:35:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- Sd convulsivo. Epilepsia secundaria
- FA con R ventricular rapida por tratamiento abandonado resuelta
- Colonización CUP
- T del ánimo
- Antecedentes

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G40.8-OTRAS EPILEPSIAS. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes mórbidos:
- ACV territorio superficial y profundo de ACM M1 izquierdo cardioembólico. Trombectomía frustra.
- Vejiga neurogénica. Retención urinaria.
- Coxoartrosis
- Antecedentes: FA en tratamiento con Dabigatran - ACV parietal posterior izquierdo no secuelado 2017 - Insuficiencia cardiaca - Hipertensión arterial - Diabetes mellitus tipo 2 NIR - Asma bronquial - Hipertiroidismo.

Medicamentos: sin uso hace al menos 3 semanas
- Aspirina 100 mg, 1 comprimido al día
- Atorvastatina 40 mg, 1 comprimido al día
- Losartan 50 mg, 1/2 comp cada 12 horas
- Bisoprolol 2,5 mg 4 comprimidoa al día
- Tiamazol 10 mg, 3 comprimidos al día
- Tamsulosina 0,4 mg, 1 comp al día
- Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 12 horas
- Lactulosa 10 cc/12 hrs
- Bromuro ipratropio 2 puff cada 6 horas por AC
- Salmeterol 2 puff c/12 hrs por AC

Social:
- Vive con esposo

Diestra mRS 5
Paciente con antecedente de ACV territorio ACM izquierda en septiembre del 2023 con trombectomía frustra. Evolución funcional favorable, logra deglución sin embargo con secuela severa de lenguaje y motora derecha.

Desde 20 diciembre con labilidad emocional, rechazo en administración de medicamentos. Al menos 3 semanas sin tratamiento.
Encontrada por hijo con movimientos repetitivos de extremidad superior izquierda y posterior generalización con estado postictal. Evaluada y trasladada por ambulancia a SU de HSC.
Al ingreso con FC 137 lpm RII, PA 184/115, T° 36°C, Sat 99% con MAF a 15 lts. Al examen en GCS 7. Se solicita estudio complementario en que destaca hiperlactatemia postictal y dimero D alto. Sin otras alteraciones de relevancia. Se realizó TC de encéfalo sin contraste en que se evidenció encefalomalacia secuelar sin sospecha de lesiones agudas.
Se presentó a teleneurología indicando carga de Levetiracetam y dosis de mantención. Se ingresa como evento cerebrovascular para estudio y tratamiento por neurología. Durante el día de ayer con aumento de secreciones bronquiales y desaturación que ceden en forma espontanea.
Se toma conocimiento del caso e 15/01/24 paciente en buenas condiciones generales, afebril, hemodinamia con tendencia a FC altas, sin apremio ventilatorio y sin desaturación. Activa y cooperadora.
Impresiona sin dolor. Se complementó estudio de laboratorio en que no se contatan hallazgos de relevanica, angioTC de cerebro y cuello con oclusión M1 izquierda ya conocida, y estudio de angioTC de torax sin evidencia de TEP.
Se decidió inicio de FAE que considerando T del animo y dificultades conductuales, se indica dosis inicial de Ac Valproico 200 mg cada 12 horas con buena tolerancia.
Una vez reiniciado tratamiento crónico con buena tolerancia, normaización de FC y buena tolerancia a la rehabilitación. Se conversa con familiares y se decide continuar cuidados con hospitalización domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido segun tolerancia pasar a sillón en forma diaria.
2. Régimen fresubin 60 cc/h agua por SNG 200 cc por 3 veces
3. Aspirina 100 mg, 1 comprimido al día
4. Atorvastatina 40 mg, 1 comprimido al día
5. Losartan 50 mg, 1/2 comp cada 12 horas
6. Bisoprolol 2,5 mg 1 comprimidoa al día
7. Tiamazol 10 mg, 3 comprimidos al día
8. Tamsulosina 0,4 mg, 1 comp al día
9. Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 12 horas en caso de dolor
10. Bromuro ipratropio 2 puff cada 6 horas por AC
11. Salmeterol 2 puff c/12 hrs por AC
12. Fonoaudiología Segumiento trastorno deglutorio para eventual retiro de SNG
13. Kinesioterapia motora
14. Control en CAE neurología 2 semanas posterior a alta.
15. Control en caso de necesidad en servicio de urgencias. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 15/01/24 Creat 0.5, MDRD 121, Uremia 27, BUN 13, ELP 137/3.4/105, Hb 12.4, hto 37.9, Leco 9600, plaq 203.000, VHS 5, Dimero D 1987, Tropo 9.2, TSH 1.68, T4L 142, VitB12 306, PCR 37, CK 31
- 15/01/24 angioTC de tórax con cardiomegalia y signos de neumopatía crónica. Sin signos de TEP.
- 15/01/24 angioTC de cerebro y cuello. Oclusión segmento M1 izquierdo.
- 13/01/24 Glic 149, Creat 0.8, MDRD 70.51. Uremia 27. BUN 13, Ureia 27, Hb 14.1, Hto 43.9, Leuco 13500, Plq 283.000, INR 1.17, TTPa 27. Dimero D 4746,5. PCR 6.9. ColT 156, HDL 49, LDL 60, TGL 236. P hepático normal. AU 8.4. Tropo 8.1
- 13/01/24 TC de encéfalo sin contraste encefalomalacia secuelar sin sospecha de lesiones agudas
- 12/01/24 Cecosf valle hondo. OC inflamatoria nitritos positivos. UC E coli, K. pneumoniae

OBSERVACIONES:

Al examen neurológico:
- Vigil, afasia global.
- Pupilas isocoricas, RFM +/+, CV con hemianopsia derecha, OCM normal. Hipoestesia facial derecha y PFC derecha. Protruye lengua en linea media
- Hemiparesia derecha braquial M0, crural M2
- Hipoestesia BC derecha
- Cerebelo no evaluado por cooperación.
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO